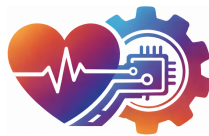




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Estimación temprana del
riesgo de inicio de
noradrenalina en UCI
mediante aprendizaje
automático y dashboard
interpretable**

Documentación Técnica

Presentado por Daniel Marina de la Cal
Daniel Marina de la Cal
en Universidad de Burgos

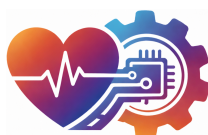
Tutores: Antonio Jesús Canepa Oneto – Sergio
Ossa Echeverri – Fernando Callejo Torre



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Estimación temprana del
riesgo de inicio de
noradrenalina en UCI
mediante aprendizaje
automático y dashboard
interpretable**

Documentación Técnica

Presentado por Daniel Marina de la Cal
Daniel Marina de la Cal
en Universidad de Burgos

29 de mayo de 2026

Tutores: Antonio Jesús Canepa Oneto – Sergio Ossa
Echeverri – Fernando Callejo Torre

Índice general

Índice general	1
Índice de figuras	3
Índice de tablas	5
Apéndice A Plan de Proyecto	7
A.1. Introducción	7
A.2. Metodología de ingeniería del software	8
A.3. Planificación temporal	9
Apéndice B Manual de especificación de diseño	13
B.1. Planos	13
B.2. Diseño arquitectónico	13
Apéndice C Especificación de Requisitos	15
C.1. Diagrama de casos de uso	15
C.2. Explicación de los casos de uso	16
C.3. Prototipo de interfaz	17
Apéndice D Documentación de usuario	23
D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto	23
D.2. Instalación / Puesta en marcha	24
D.3. Manuales y demostraciones prácticas	24
Apéndice E Manual del desarrollador / programador / investigador.	27
E.1. Estructura de directorios	27

E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	27
E.3. Pruebas del sistema	27
E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto. . .	28
Apéndice F Descripción de adquisición y tratamiento de datos	29
F.1. Descripción formal de los datos	29
F.2. Descripción clínica de los datos.	29
Apéndice G Estudio experimental	33
G.1. Cuaderno de trabajo.	33
G.2. Configuración y parametrización de las técnicas.	33
G.3. Detalle de resultados.	33
Apéndice H Anexo de sostenibilización curricular	35
H.1. Definición de Sostenibilidad en el Contexto del TFG	35
H.2. Principios Genéricos de Sostenibilidad Aplicados	35
H.3. Desarrollo de Competencias Transversales (SOS)	36
Apéndice I Registro de interacciones con sistemas de IA	39
I.1. Registro de interacciones con sistemas de IA	39
Bibliografía	41

Índice de figuras

A.1. Planificación inicial del proyecto (marzo – junio 2026).	9
A.2. Ejecución real del proyecto (marzo – junio 2026).	9
B.1. Arquitectura del sistema: pipeline de modelado (entrenamiento) y aplicación de visualización (inferencia), desacoplados a través de los modelos serializados en <code>.pkl</code>	14
C.1. Diagrama de casos de uso del <i>dashboard</i>	16
C.2. Pantalla de inicio del <i>dashboard</i> . Bajo el título se muestra el aviso permanente de prototipo de investigación y los controles de selección de ventana temporal, modo demostración y manual. La aplicación no realiza ninguna acción hasta que el usuario selecciona una opción.	17
C.3. Vista principal tras cargar la analítica de un paciente (ventana larga, 12–48 h). A la izquierda, el percentil de riesgo acompañado de su explicación textual y de los datos del paciente; a la derecha, los factores de riesgo individuales según los valores SHAP, donde las barras rojas empujan el riesgo al alza y las verdes lo reducen.	18
C.4. Modo demostración. Permite explorar el funcionamiento del <i>dash- board</i> con casos ficticios, sin necesidad de cargar un CSV real. Se muestra un caso de paciente con deterioro hemodinámico (riesgo alto esperado), con la tabla de datos del caso y el percentil resultante.	18
C.5. Manual de uso integrado, accesible desde la propia interfaz. Do- cumenta las ventanas temporales disponibles, el modo de uso, el formato del CSV de entrada y la interpretación del percentil de riesgo y de los valores SHAP.	19

F.1. Relación entre peso del vehículo y consumo (mpg) en mtcars . . .	31
---	----

Índice de tablas

A.1. Estimación de costes del proyecto.	10
C.1. CU-1 Cargar datos clínicos del paciente.	20
C.2. CU-2 Consultar el riesgo estimado.	21
C.3. CU-3 Consultar la explicación de la predicción.	22
F.1. Resumen estadístico del conjunto de datos mtcars	30

Apéndice A

Plan de Proyecto

A.1. Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo y validación de modelos de aprendizaje automático para la estimación temprana del riesgo de inicio de noradrenalina en pacientes adultos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), utilizando variables clínicas y analíticas disponibles durante las primeras horas de estancia. La motivación clínica reside en la necesidad de anticipar qué pacientes requerirán soporte vasopresor, lo que podría proporcionar una ventana terapéutica para una intervención más temprana y, en su caso, apoyar la priorización de pacientes y recursos.

El alcance del trabajo comprende tres componentes principales: la construcción de cohortes y el desarrollo de modelos predictivos sobre la base de datos MIMIC-IV [Johnson et al. \(2023\)](#), con evaluación interna mediante validación cruzada anidada; la validación externa sobre la base de datos multicéntrica eICU-CRD [Pollard et al. \(2018\)](#), que permite evaluar la generalización de los modelos a entornos clínicos distintos del de desarrollo; y el desarrollo de un prototipo de *dashboard* clínico interpretable implementado en Streamlit, orientado a demostrar la viabilidad de integrar los modelos en una interfaz funcional a pie de cama.

El proyecto no incluye validación prospectiva ni despliegue clínico en entorno asistencial real, por lo que se enmarca como investigación aplicada y prueba de concepto. Las consideraciones metodológicas, económicas y legales relevantes se desarrollan en los apartados siguientes.

A.2. Metodología de ingeniería del software

La metodología seguida durante el desarrollo se describe en detalle en la sección de Metodología de la memoria. En síntesis, se empleó un enfoque **experimental e iterativo** con un ciclo incremental por versiones, código organizado en módulos funcionales y control de versiones con Git y GitHub. Este enfoque se corresponde con un modelo de desarrollo **iterativo e incremental**, próximo al prototipado evolutivo: cada versión del flujo de trabajo se construyó sobre la anterior y se refinó en función de los resultados obtenidos, sin un diseño cerrado definido a priori.

Esta naturaleza iterativa queda reflejada en la propia estructura del repositorio, cuyas sucesivas carpetas de pruebas documentan la evolución del trabajo: desde los primeros ensayos por ventana sobre MIMIC-IV, pasando por los refinamientos de la cohorte general (versiones I a III, incluyendo la eliminación de registros incompletos y la restricción de la ventana temporal) y el análisis del subgrupo de sepsis, hasta las versiones finales del modelo (v4.2 a v4.4) y la validación externa sobre eICU-CRD.

Las fases principales llevadas a cabo fueron:

1. Revisión bibliográfica y definición del problema.
2. Acceso a datos: formación CITI y registro en PhysioNet.
3. Construcción de cohortes (SQL) sobre MIMIC-IV y eICU-CRD.
4. Preprocesamiento y selección de variables.
5. Entrenamiento, optimización y evaluación interna (validación cruzada anidada).
6. Calibración de probabilidades e interpretabilidad (SHAP).
7. Validación externa sobre eICU-CRD.
8. Desarrollo del prototipo de *dashboard* y encuesta.
9. Redacción de la memoria y documentación del repositorio.

El ciclo de vida no está completo: quedan fuera del alcance de este TFG la validación externa con datos del Hospital Universitario de Burgos y la validación prospectiva en entorno clínico real, así como la integración del *dashboard* en los sistemas de información sanitarios.

Si se deseara continuar con el presente trabajo para dejar lista y validada una herramienta clínica, se recomienda una metodología Scrum [Sutherland and Sutherland \(2014\)](#), primero porque permite incorporar el *feedback* continuo de los clínicos en sprints cortos y porque es de las metodologías más extendidas en el desarrollo de herramientas software, por ende, una de las metodologías con la que más desarrolladores están familiarizados.

A.3. Planificación temporal

La planificación inicial propuesta se representa en la Figura A.1 y la finalmente seguida en la Figura A.2.



Figura A.1: Planificación inicial del proyecto (marzo – junio 2026).



Figura A.2: Ejecución real del proyecto (marzo – junio 2026).

Leyenda de colores:

- **Amarillo:** tarea no realizada, sustituida por la obtención y uso de eICU-CRD como cohorte de validación externa.
- **Rojo:** retraso en el inicio de la tarea respecto a la planificación inicial.
- **Barras rojas:** tiempo adicional necesario para completar la tarea.
- **Verde:** tarea finalizada antes de lo previsto.
- **Barras verdes:** tarea iniciada con anterioridad a lo planificado.

Las desviaciones respecto a la planificación inicial se debieron principalmente a dos causas. Los retrasos se produjeron al encontrar dificultades no

anticipadas o al haber subestimado la complejidad de determinadas tareas. Los adelantos respondieron al motivo contrario: tareas cuya dificultad o duración resultó inferior a la estimada inicialmente.

El seguimiento del proyecto se organizó en GitHub mediante *milestones* e *issues*, agrupando las tareas en siete fases: (1) obtención de datos y formación CITI/PhysioNet, (2) trámites universitarios y comités de ética, (3) investigación inicial y estado del arte, (4) definición de la cohorte y extracción de MIMIC-IV, (5) validación externa sobre eICU-CRD, (6) desarrollo del *dashboard* y (7) redacción de la memoria y los anexos. Las cinco primeras fases se completaron en su totalidad; el desarrollo del *dashboard* y la redacción de la memoria constituyeron la etapa final del trabajo, concentrada en las últimas semanas de mayo y primera de junio. La experimentación interna —entrenamiento, calibración e iteración sucesiva de los modelos— se gestionó por versiones en el repositorio en lugar de como un *milestone* independiente, tal como refleja la sucesión de carpetas de pruebas descrita en el apartado anterior.

Planificación económica

La Tabla A.1 recoge la estimación de costes materiales del proyecto. Al tratarse de un trabajo académico, no se consideran costes de recursos humanos en sentido profesional.

Tabla A.1: Estimación de costes del proyecto.

Categoría	Concepto	Coste
Hardware	Amortización portátil (uso parcial)	100 €
Software	Código abierto	0 €
Datos	MIMIC-IV y eICU-CRD (PhysioNet)	0 €
Total		100 €

Para el desarrollo del proyecto se utilizó un equipo HP Pavilion Plus con procesador Intel Core i7 Ultra, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica Nvidia RTX 4050 con 6 GB de VRAM, adquirido en febrero de 2026 por 1.500 €. Dado que el equipo no se destinó de forma exclusiva al proyecto y se aprovechará a lo largo de toda su vida útil, se ha estimado una amortización parcial de 100 € correspondiente a los meses de uso efectivo durante el trabajo.

Aunque la GPU dedicada permitió reducir los tiempos de entrenamiento, el trabajo habría podido desarrollarse con un equipo de menores prestaciones, siempre que dispusiese de al menos 200 GB de almacenamiento libre para albergar las bases de datos completas de MIMIC-IV y eICU-CRD junto con los ficheros de código.

Viabilidad legal

El acceso a las bases de datos empleadas, MIMIC-IV [Johnson et al. \(2023\)](#) y eICU-CRD [Pollard et al. \(2018\)](#), requirió completar el curso de formación en ética en investigación con datos humanos del CITI Program (CITI Program, 2026) y firmar el acuerdo de uso de datos de PhysioNet (PhysioNet, 2026). Dicho acuerdo establece las siguientes obligaciones: no reidentificar a los pacientes, no redistribuir los datos originales, y publicar el código desarrollado en un repositorio público. El repositorio del presente proyecto, disponible en GitHub, cumple con este último requisito.

Al tratarse de un análisis retrospectivo sobre bases de datos públicas completamente desidentificadas por sus custodios originales, no se requirió la aprobación de ningún Comité de Ética de Investigación para el desarrollo de este trabajo. No obstante, para continuar con una validación externa con datos del Hospital Universitario de Burgos o validar el *dashboard* como herramienta clínica, se precisaría la aprobación del Comité de Ética en Investigación de dicho centro.

Apéndice *B*

Manual de especificación de diseño

B.1. Planos

No procede. Al tratarse de un proyecto de software desarrollado íntegramente sobre bases de datos clínicas públicas, sin componente hardware ni despliegue físico de dispositivos, no existen planos técnicos que documentar. Las características del equipo empleado se detallan en el Apéndice A (Planificación económica).

B.2. Diseño arquitectónico

El sistema se estructura en dos subsistemas desacoplados: un **pipeline de modelado**, que transforma los datos clínicos en modelos predictivos entrenados y serializados, y una **aplicación de visualización** (*dashboard*), que consume dichos modelos para ofrecer estimaciones individualizadas. La Figura [B.1](#) resume el flujo general.

El pipeline de modelado sigue una secuencia lineal de etapas: extracción de las cohortes mediante consultas SQL sobre MIMIC-IV y eICU-CRD; preprocesamiento (filtro de completitud, tratamiento de valores extremos y selección de variables); entrenamiento y optimización de hiperparámetros mediante validación cruzada anidada; calibración de probabilidades; y serialización de los modelos finales en formato `.pkl` mediante `joblib`, lo que permite su reutilización posterior sin reentrenamiento.

La aplicación de visualización, implementada en Streamlit, carga los modelos serializados y, a partir de un CSV con las mediciones de un paciente, calcula los estadísticos agregados requeridos, obtiene la probabilidad estimada, la traduce a un percentil de riesgo respecto a la distribución de MIMIC-IV y muestra la explicación individual mediante valores SHAP. Ambos subsistemas se comunican exclusivamente a través de los artefactos serializados, de modo que el entrenamiento y la inferencia quedan completamente separados.

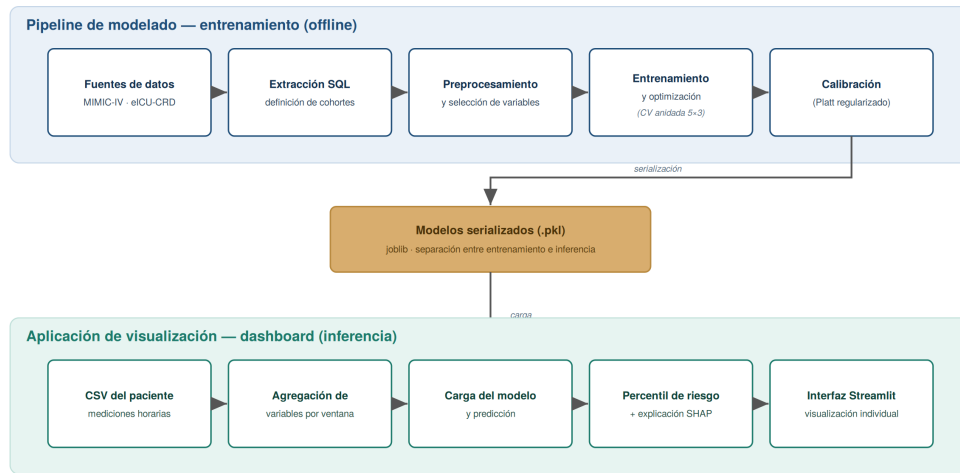


Figura B.1: Arquitectura del sistema: pipeline de modelado (entrenamiento) y aplicación de visualización (inferencia), desacoplados a través de los modelos serializados en `.pkl`.

Apéndice C

Especificación de Requisitos

C.1. Diagrama de casos de uso

El único subsistema interactivo del trabajo es el *dashboard*; el pipeline de modelado se ejecuta de forma desatendida y no tiene usuario que interactúe con él, por lo que los casos de uso modelan exclusivamente la aplicación de visualización. Cabe señalar que el *dashboard* es un **prototipo académico** (versión 0.1, en fase de prueba de concepto), sin validación clínica prospectiva ni autorización regulatoria, no apto para uso asistencial real. El actor único es el **facultativo de Medicina Intensiva**. La Figura C.1 resume las funcionalidades.

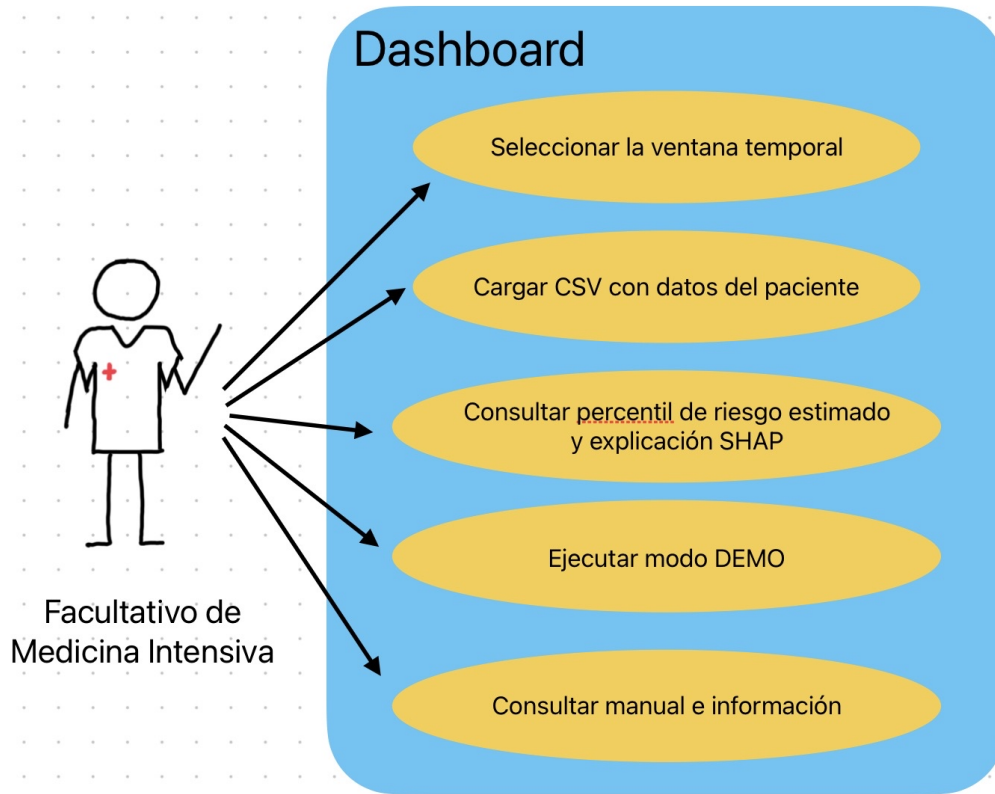


Figura C.1: Diagrama de casos de uso del *dashboard*.

C.2. Explicación de los casos de uso

A modo de contexto, los casos de uso se apoyan en los siguientes requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF):

Requisitos funcionales:

- **RF-1:** permitir seleccionar la ventana temporal de predicción (6–24 h o 12–48 h).
- **RF-2:** permitir cargar un fichero CSV con las mediciones del paciente.
- **RF-3:** calcular los estadísticos agregados a partir de las mediciones.
- **RF-4:** mostrar el riesgo estimado como percentil respecto a la distribución de MIMIC-IV.
- **RF-5:** mostrar la explicación individual de la predicción mediante valores SHAP.

- **RF-6:** disponer de un modo demostración con datos de ejemplo.
- **RF-7:** ofrecer un manual de uso y un aviso de prototipo sin validación clínica.

Requisitos no funcionales:

- **RNF-1 (interpretabilidad):** las salidas deben ser comprensibles para personal clínico.
- **RNF-2 (no prescriptivo):** la interfaz no emite recomendaciones clínicas automáticas; es una herramienta de apoyo.
- **RNF-3 (usabilidad):** interfaz sencilla, manejable a pie de cama.
- **RNF-4 (privacidad):** no se almacenan ni transmiten datos identificables del paciente.
- **RNF-5 (portabilidad):** la aplicación debe poder ejecutarse en cualquier equipo con un entorno Python estándar y las dependencias del proyecto instaladas, sin requerir hardware especializado.
- **RNF-6 (estado del producto):** la aplicación es un prototipo académico (versión 0.1) de prueba de concepto, sin validación clínica prospectiva ni autorización regulatoria; no está destinada a uso asistencial real.

C.3. Prototipo de interfaz



Última actualización: 29/05/2026 01:59:13

Figura C.2: Pantalla de inicio del *dashboard*. Bajo el título se muestra el aviso permanente de prototipo de investigación y los controles de selección de ventana temporal, modo demostración y manual. La aplicación no realiza ninguna acción hasta que el usuario selecciona una opción.

Especificación de Requisitos

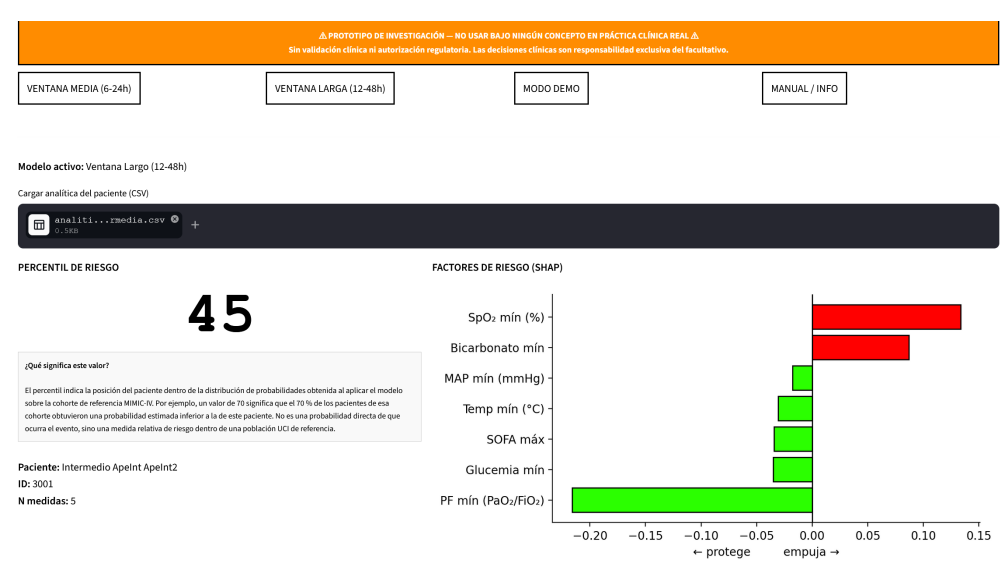


Figura C.3: Vista principal tras cargar la analítica de un paciente (ventana larga, 12–48 h). A la izquierda, el percentil de riesgo acompañado de su explicación textual y de los datos del paciente; a la derecha, los factores de riesgo individuales según los valores SHAP, donde las barras rojas empujan el riesgo al alza y las verdes lo reducen.

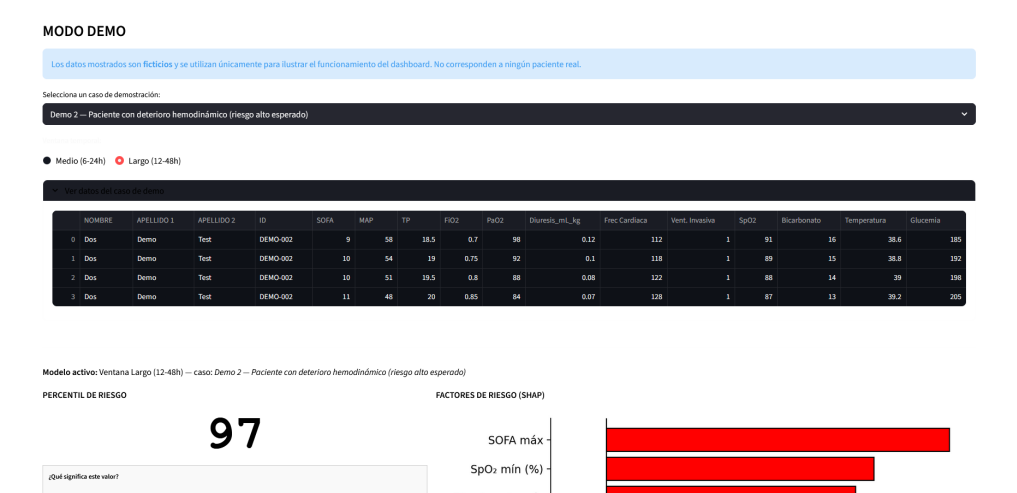


Figura C.4: Modo demostración. Permite explorar el funcionamiento del *dashboard* con casos ficticios, sin necesidad de cargar un CSV real. Se muestra un caso de paciente con deterioro hemodinámico (riesgo alto esperado), con la tabla de datos del caso y el percentil resultante.

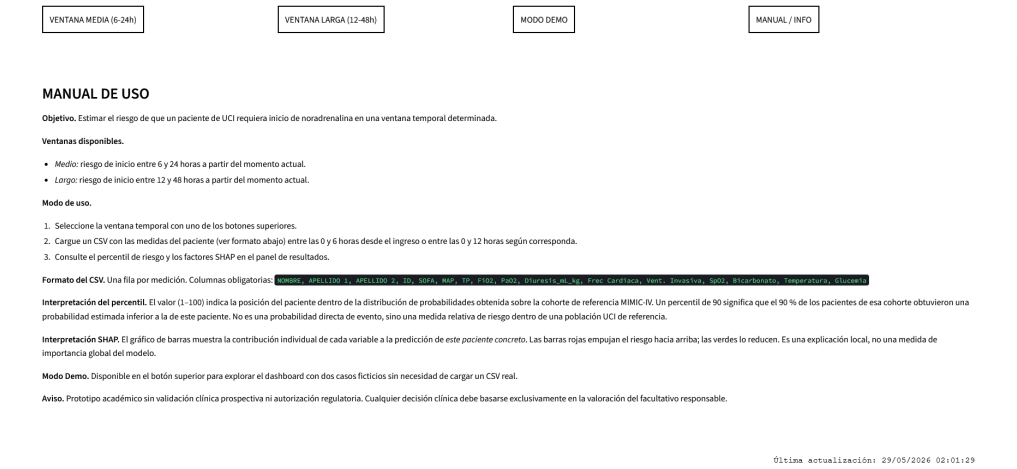


Figura C.5: Manual de uso integrado, accesible desde la propia interfaz. Documenta las ventanas temporales disponibles, el modo de uso, el formato del CSV de entrada y la interpretación del percentil de riesgo y de los valores SHAP.

CU-1	Cargar datos clínicos del paciente
Versión del caso de uso	1.0
Autor	Daniel Marina de la Cal
Requisitos asociados	RF-2, RF-3
Descripción	El facultativo carga un fichero CSV con las mediciones del paciente para obtener una estimación de riesgo.
Precondición	Haber seleccionado una ventana temporal y disponer de un CSV con el formato esperado.
Acciones	1. El facultativo selecciona la opción de carga de datos. 2. Elige el fichero CSV del paciente. 3. El sistema valida el formato y calcula los estadísticos agregados. 4. El sistema habilita la consulta del riesgo y la explicación.
Postcondición	Los datos del paciente quedan cargados y procesados en la sesión.
Excepciones	Si el CSV tiene un formato inválido o faltan columnas, el sistema muestra un aviso de error y no procesa los datos.
Importancia	Alta

Tabla C.1: CU-1 Cargar datos clínicos del paciente.

CU-2		Consultar el riesgo estimado
Versión del caso de uso	1.0	
Autor	Daniel Marina de la Cal	
Requisitos asociados	RF-4	
Descripción	El facultativo consulta el riesgo estimado de inicio de noradrenalina, expresado como percentil respecto a la población de referencia.	
Precondición	Datos del paciente cargados y procesados (CU-1).	
Acciones	1. El sistema aplica el modelo de la ventana seleccionada. 2. Calcula la probabilidad y la traduce a un percentil respecto a MIMIC-IV. 3. Muestra el percentil de riesgo del paciente.	
Postcondición	Se muestra el percentil de riesgo estimado.	
Excepciones	—	
Importancia	Alta	

Tabla C.2: CU-2 Consultar el riesgo estimado.

CU-3	Consultar la explicación de la predicción
Versión del caso de uso	1.0
Autor	Daniel Marina de la Cal
Requisitos asociados	RF-5, RNF-1
Descripción	El facultativo consulta qué variables contribuyen a aumentar o reducir el riesgo estimado para el paciente concreto.
Precondición	Predicción calculada (CU-2).
Acciones	1. El sistema calcula los valores SHAP individuales. 2. Muestra, ordenadas, las variables que empujan o reducen el riesgo.
Postcondición	Se muestra la explicación individualizada de la predicción.
Excepciones	—
Importancia	Media-alta

Tabla C.3: CU-3 Consultar la explicación de la predicción.

Apéndice *D*

Documentación de usuario

D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto

Conviene distinguir entre el entorno de *entrenamiento* y el de *uso del dashboard*. Esta documentación se refiere a este último: la ejecución de la aplicación de visualización, que únicamente carga los modelos ya entrenados y procesa un fichero reducido de datos de un paciente. Por tanto, no requiere descargar las bases de datos MIMIC-IV ni eICU-CRD.

Requisitos de hardware (mínimos):

- Cualquier ordenador personal moderno con 4 GB de RAM o más.
- Aproximadamente 500 MB de espacio libre para el entorno de Python y las dependencias (los modelos ocupan menos de 1 MB).
- No se requiere tarjeta gráfica dedicada: la inferencia se ejecuta en CPU.

Requisitos de software:

- Python 3.12 o superior.
- Las siguientes bibliotecas: `streamlit`, `pandas`, `numpy`, `scikit-learn`, `xgboost`, `shap`, `matplotlib` y `joblib`.
- Un navegador web actualizado (la interfaz de Streamlit se abre en el navegador).

D.2. Instalación / Puesta en marcha

La puesta en marcha descrita a continuación correspondería a personal técnico; el usuario final (el facultativo) interactúa únicamente con la interfaz ya en ejecución, descrita en la sección siguiente.

La aplicación se distribuye en la carpeta **Dashboard** del repositorio, que contiene el script `pruebas_dashboard.py`, los dos modelos serializados (`modelo_Medio_6_24_XGB_calibrado.pkl` y `modelo_Largo_12_48_XGB.pkl`) y los dos ficheros de referencia de percentiles (`referencia_percentiles_medio.npy` y `referencia_percentiles_largo.npy`). Los pasos para ponerla en marcha son los siguientes:

1. Clonar el repositorio del proyecto desde GitHub (o descargar la carpeta **Dashboard** completa).
2. Instalar las dependencias:

```
pip install streamlit pandas numpy scikit-learn xgboost shap matplotlib joblib
```

3. Situar en la carpeta **Dashboard** y lanzar la aplicación:

```
streamlit run pruebas_dashboard.py
```

4. La aplicación se abrirá automáticamente en el navegador (por defecto, en `http://localhost:8501`). Es imprescindible que los ficheros `.pkl` y `.npy` se encuentren en la misma carpeta que el script.

D.3. Manuales y demostraciones prácticas

La interfaz incorpora un manual de uso accesible desde el propio *dashboard* (botón *Manual / Info*). Las capturas de las distintas pantallas se recogen en el Apéndice C (Figuras C.2 a C.5). El flujo de uso es el siguiente:

1. **Seleccionar la ventana temporal.** Mediante los botones superiores se elige la ventana *Media* (riesgo de inicio entre 6 y 24 h) o *Larga* (entre 12 y 48 h).

2. **Cargar los datos del paciente.** Se carga un fichero CSV con una fila por medición. Las columnas obligatorias son: NOMBRE, APELLIDO 1, APELLIDO 2, ID, SOFA, MAP, TP, FiO2, PaO2, Diuresis_mL_kg, Frec Cardiaca, Vent. Invasiva, SpO2, Bicarbonato, Temperatura, Glucemia.
3. **Consultar el resultado.** La aplicación muestra el percentil de riesgo (de 1 a 100) y, a su derecha, los factores de riesgo individuales según los valores SHAP.

Interpretación del percentil. El valor indica la posición del paciente dentro de la distribución de probabilidades obtenida sobre la cohorte de referencia MIMIC-IV. Un percentil de 90 significa que el 90 % de los pacientes de esa cohorte obtuvieron una probabilidad estimada inferior a la de este paciente. No es una probabilidad directa de que ocurra el evento, sino una medida relativa de riesgo.

Interpretación de los valores SHAP. El gráfico de barras muestra la contribución de cada variable a la predicción de *ese paciente concreto*: las barras que empujan el riesgo al alza y las que lo reducen. Es una explicación local de la predicción, no una medida de importancia global del modelo.

Modo demostración. Accesible desde el botón *Modo Demo*, permite explorar el funcionamiento de la aplicación con casos ficticios, sin necesidad de cargar un CSV real. Resulta útil para familiarizarse con la interfaz antes de introducir datos propios.

Aviso. La aplicación es un prototipo académico sin validación clínica prospectiva ni autorización regulatoria, no apto para uso asistencial real. Este aviso se muestra de forma permanente en la parte superior de la interfaz.

““=latex

Apéndice E

Manual del desarrollador / programador / investigador.

E.1. Estructura de directorios

Descripción de la estructura de carpetas y archivos entregados junto con el proyecto.

E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

En caso necesario, se detallarán los pasos técnicos para compilar, instalar y ejecutar el proyecto.

E.3. Pruebas del sistema

Esta sección puede ser opcional.

Se describirán las pruebas realizadas para validar el correcto funcionamiento del sistema, tales como pruebas unitarias, funcionales o validaciones con usuarios.

E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto.

Se proporcionarán indicaciones y recomendaciones para facilitar futuras ampliaciones o mejoras del trabajo realizado.

Apéndice *F*

Descripción de adquisición y tratamiento de datos

F.1. Descripción formal de los datos

Se describirá el tipo de datos utilizados, su formato, origen, volumen y características principales. Tablas, imágenes, señales, secuencias de ADN...

F.2. Descripción clínica de los datos.

Descripción y explicaciones clínicas del significado o interpretación de los datos.

A continuación se muestra un **ejemplo de análisis exploratorio con R** que produce tanto código visible como tabla y figura en el PDF:

```
library(knitr)
library(dplyr)

mtcars |>
  select(mpg, cyl, hp, wt) |>
  summarise(across(everything(),
    list(media = mean, sd = sd, min = min, max = max),
    .names = "{.col}_{.fn}"
  )) |>
  tidyr::pivot_longer(everything(),
    names_to = c("variable", "estadístico"),
```

Tabla F.1: Resumen estadístico del conjunto de datos mtcars

Variable	Media	SD	Mín	Máx
mpg	20.09	6.03	10.40	33.90
cyl	6.19	1.79	4.00	8.00
hp	146.69	68.56	52.00	335.00
wt	3.22	0.98	1.51	5.42

```
names_sep = "_"
) |>
tidyr::pivot_wider(names_from = estadístico, values_from = value) |>
mutate(across(where(is.numeric), \(x) round(x, 2))) |>
kable(booktabs = TRUE, format = "latex",
      col.names = c("Variable", "Media", "SD", "Mín", "Máx"))
```

```
library(ggplot2)

ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) +
  geom_point(aes(color = factor(cyl)), size = 2.5) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "grey40") +
  labs(
    x = "Peso (1000 lbs)",
    y = "Consumo (mpg)",
    color = "Cilindros"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 11)
```

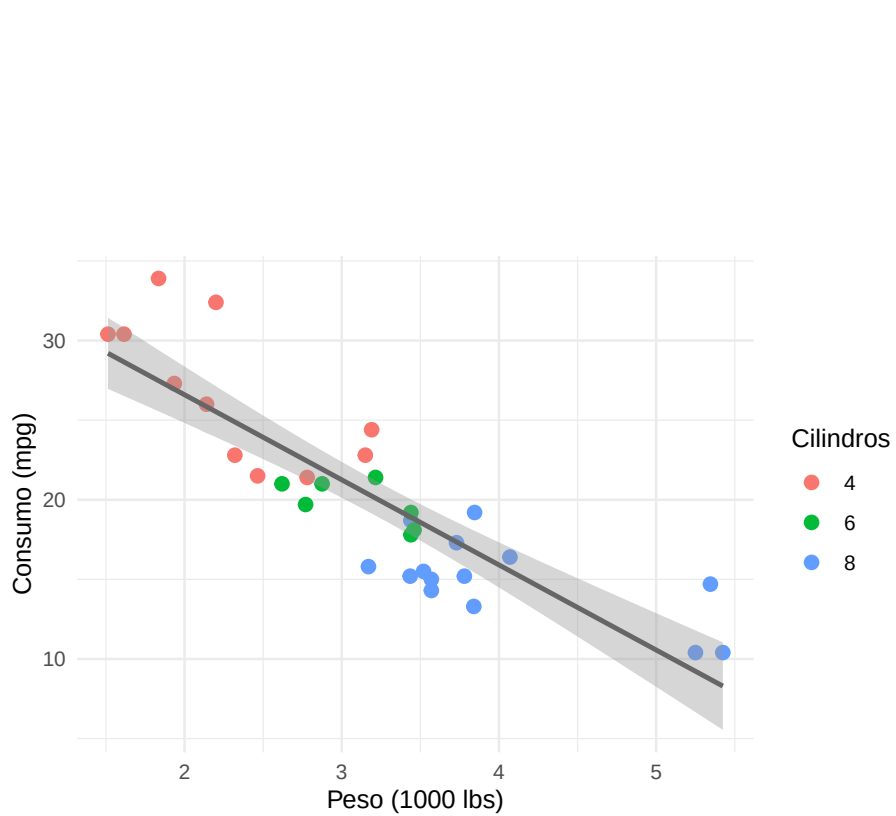


Figura F.1: Relación entre peso del vehículo y consumo (mpg) en mtcars

Apéndice G

Estudio experimental

G.1. Cuaderno de trabajo.

Se enumerarán los experimentos realizados durante el proyecto, incluyendo tanto los resultados satisfactorios como aquellos que no hayan sido exitosos.

G.2. Configuración y parametrización de las técnicas.

Se detallarán los parámetros utilizados en los experimentos y la justificación de su elección.

G.3. Detalle de resultados.

Se presentarán los resultados obtenidos mediante tablas, figuras y métricas relevantes.

Anexo de sostenibilización curricular

H.1. Definición de Sostenibilidad en el Contexto del TFG

Siguiendo las directrices de la CRUE, la sostenibilidad no es solo cuidar el medio ambiente; es un compromiso ético que busca la calidad ambiental, la justicia social y una economía equitativa y viable a largo plazo. Hablar de sostenibilidad implica promover la salud de la población, garantizar el acceso igualitario a las tecnologías de la información y gestionar de forma justa los recursos disponibles.

Este Trabajo de Fin de Grado aplica estos conceptos directamente al entorno de los cuidados intensivos. No se trata de un desarrollo de software aislado, sino de una herramienta de ingeniería de la salud diseñada para ayudar a gestionar recursos sanitarios críticos y mejorar la atención de las personas en un momento de máxima vulnerabilidad.

H.2. Principios Genéricos de Sostenibilidad Aplicados

El proyecto se alinea de forma directa con los principios básicos de la CRUE mediante las siguientes acciones:

- **Principio Ético y Holístico:** Sitúa la protección de la vida como objetivo principal al intentar anticipar el deterioro de pacientes en la UCI. Además, mediante el uso de valores SHAP, se rechaza el modelo de “caja negra”, garantizando que el médico entienda la predicción y se respete la seguridad del paciente de forma justa e integral.
- **Principio de Complejidad y Glocalización:** El shock hemodinámico es un problema médico complejo que requiere combinar la ingeniería de datos con la medicina de precisión. Para resolverlo, se han usado bases de datos globales (MIMIC-IV y eICU-CRD) pero adaptando el resultado a la realidad local y las necesidades del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).
- **Principio de Transversalidad y Responsabilidad Social:** La sostenibilidad se ha integrado en el diseño del software (buscando la eficiencia del código informático) y devuelve un valor real a la sociedad mediante la colaboración directa entre la Universidad de Burgos y el servicio de salud público.

H.3. Desarrollo de Competencias Transversales (SOS)

Para cumplir con la formación universitaria en desarrollo humano sostenible, este trabajo desarrolla de forma práctica las cuatro competencias transversales exigidas por la normativa:

SOS1.- Contextualización crítica del conocimiento

Esta competencia se cumple al interrelacionar los datos clínicos con la problemática social y económica de los hospitales. El coste humano y económico de un fallo multiorgánico en la UCI es enorme y afecta a la sostenibilidad del sistema sanitario. El modelo desarrollado no se limita a calcular probabilidades matemáticas; analiza de forma crítica variables heterogéneas para entender el riesgo de forma global y local, ayudando a tomar mejores decisiones asistenciales basadas en la evidencia.

SOS2.- Utilización sostenible de recursos y prevención de impactos

El proyecto aborda este punto en dos niveles diferenciados:

1. **Recursos sanitarios:** Anticipar la necesidad de noradrenalina permite una mejor planificación de camas, personal y material en la UCI. Esto ayuda a reducir estancias hospitalarias innecesarias y disminuye el desperdicio de recursos fungibles de alto coste.
2. **Recursos computacionales:** En lugar de entrenar redes neuronales masivas con un alto consumo energético, se han seleccionado algoritmos de árboles eficientes (XGBoost y CatBoost) y se ha optimizado la búsqueda de hiperparámetros mediante validación cruzada anidada para minimizar el tiempo de cómputo y la huella de carbono digital del proyecto.

SOS3.- Participación en procesos comunitarios

La competencia se materializa en la colaboración con la comunidad local, concretamente con el personal médico del HUBU. El dashboard desarrollado se sometió a una encuesta de satisfacción con ocho facultativos del servicio de Medicina Intensiva. Sus opiniones permitieron validar la utilidad real del sistema a pie de cama y abrieron debates sobre cómo reenfocar la herramienta hacia áreas de urgencias o planta médica para mejorar la monitorización comunitaria.

SOS4.- Aplicación de principios éticos en el comportamiento profesional

Como futuro ingeniero de la salud, el desarrollo de este TFG se ha guiado por la responsabilidad profesional y el respeto a los derechos humanos:

- Se ha garantizado el seguimiento de las restricciones de Physionet acerca del uso de las BBDD eICU y MIMIC-IV, sin redistribuirse ni publicarse en ningún momento ni las tablas originales ni las postprocesadas.
- El código se ha publicado de forma abierta y transparente en GitHub para fomentar la reproducibilidad científica y el acceso libre al conocimiento.
- El diseño del dashboard deja claro que la inteligencia artificial es solo una herramienta de apoyo; la decisión final siempre es del médico, respetando el principio humanista de la práctica médica.

Apéndice I

Registro de interacciones con sistemas de IA

I.1. Registro de interacciones con sistemas de IA

Este anexo tiene como objetivo garantizar la transparencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa durante la realización del Trabajo de Fin de Grado. En él se deberá incluir un registro ordenado de los *prompts*, solicitudes, o peticiones formuladas por el estudiante en las interacciones con sistemas de IA que hayan sido más significativas en relación al desarrollo del TFG. Asimismo se incluirán bien las respuestas generadas directamente por los sistemas de IA, o bien se reflejará la importancia que ha tenido esa interacción en el desarrollo del trabajo (código, texto, enfoque...) de esas interacciones significativas.

El propósito de este anexo no es penalizar el uso de inteligencia artificial, sino documentarlo de forma clara, permitiendo al tribunal evaluar el alcance, la finalidad y el impacto real de dichas herramientas en el proceso de aprendizaje y en los resultados obtenidos. El uso de IA debe entenderse como una herramienta de apoyo, nunca como un sustituto del razonamiento, la toma de decisiones técnicas o la autoría del trabajo.

Para cada interacción relevante con sistemas de IA, se deberá indicar, al menos, la siguiente información:

- Herramienta o modelo de IA utilizado.
- Fecha aproximada de uso.

Registro de interacciones con sistemas de IA

- Prompt/petición/solicitud/forma de uso realizada por el estudiante.
- Respuesta completa generada por la IA (opcional)
- Uso posterior de dicha respuesta en el TFG (orientación conceptual, mejora de redacción, generación de ideas, apoyo técnico, generación de código, etc.).

Este anexo podrá estructurarse en forma de tablas o listados numerados, y solo deberá incluir aquellas interacciones que hayan tenido una influencia significativa en el desarrollo del trabajo.

Bibliografía

- Johnson, A. E. W., Bulgarelli, L., Shen, L., et al. (2023). MIMIC-IV, a freely accessible electronic health record dataset. *Scientific Data*, 10(1):1.
- Pollard, T. J., Johnson, A. E. W., Raffa, J. D., Celi, L. A., Mark, R. G., and Badawi, O. (2018). The eICU collaborative research database, a freely available multi-center database for critical care research. *Scientific Data*, 5:180178.
- Sutherland, J. and Sutherland, J. J. (2014). *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time*. Crown Business, New York.